

Rx - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

UTROGESTAN® 100 mg. Progesterone

UTROGESTAN® 200 mg. Progesterone

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN, CÔNG THỨC THUỐC

Hoạt chất: Mỗi viên có chứa:

Utrogestan 100 mg: progesterone dạng bột siêu mịn (progesterone micronized) 100 mg

Utrogestan 200 mg: progesterone dạng bột siêu mịn (progesterone micronized) 200 mg

Thành phần tá dược: dầu hướng dương, lecithin đậu nành.

Thành phần vỏ nang mềm: gelatin, glycerol, titan dioxit (E171)

DẠNG BẢO CHẾ

Viên nang mềm dùng uống hoặc đặt âm đạo

CHỈ ĐỊNH

Đường uống

Phụ khoa:

- Những rối loạn liên quan đến thiếu hụt progesterone, như hội chứng tiền kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều do rối loạn rụng trứng hay không rụng trứng, bệnh vú lành tính, tiền mãn kinh
- Mãn kinh (bổ sung cho liệu pháp estrogen)
- Vô sinh do suy hoàng thể

Sản khoa:

- Dọa sảy thai hoặc dự phòng sảy thai liên tiếp do suy hoàng thể
- Dọa sinh non

Đường âm đạo

- Hiếm muộn, vô sinh nguyên phát hay thứ phát do suy một phần hay hoàn toàn hoàng thể (đặc biệt trong rối loạn rụng trứng, bổ sung giai đoạn hoàng thể trong thụ tinh ống nghiệm, hiến trứng).
- Dọa sảy thai hoặc dự phòng dọa sảy thai liên tiếp do suy hoàng thể.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG

Đường uống

Liều trung bình từ 200 đến 300 mg progesterone mỗi ngày chia làm 1 đến 2 lần, nghĩa là dùng 200 mg vào buổi tối trước khi đi ngủ và 100 mg vào buổi sáng nếu cần.

- Trong suy hoàng thể (hội chứng tiền kinh nguyệt, bệnh vú lành tính, kinh nguyệt không đều, tiền mãn kinh): điều trị 10 ngày mỗi chu kỳ, thường từ ngày thứ 17 đến ngày thứ 26.
- Trong liệu pháp hormon thay thế: liệu pháp estrogen đơn thuần không thích hợp, progesterone được dùng kết hợp trong 2 tuần cuối của đợt điều trị, tiếp theo ngưng mọi điều trị thay thế trong khoảng 1 tuần, trong thời gian đó có thể có xuất huyết khi ngưng

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chú ý ở người lái xe hoặc sử dụng máy móc, thuốc này có thể gây buồn ngủ và/hoặc chóng mặt khi dùng đường uống. Để tránh tác dụng phụ này nên uống thuốc vào buổi tối.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC

Dùng kết hợp với các thuốc khác có thể làm ảnh hưởng chuyển hóa của progesterone, có thể thay đổi hiệu quả của thuốc như:

- Thuốc gây cảm ứng men CYP450-3A4 mạnh như các thuốc barbiturat, thuốc chống động kinh (phenytoin, carbamazepin), rifampicin, phenylbutazon, spironolacton, griseofulvin và một số kháng sinh (các ampicillin, tetracyclin), một số thuốc từ dược liệu có chứa St.John's wort (*Hypericum perforatum*): những thuốc này làm tăng chuyển hóa và thải trừ của progesterone.
- Ketonazol và một số thuốc ức chế CYP450-3A4 như ritonavir và nelfinavir có thể làm tăng sinh khả dụng của progesteron. Chuyển hóa của progesterone ở microsom gan bị ức chế bởi ketonazol ($IC_{50} < 0,1 \mu M$).
- Các progestin có thể làm giảm hấp thu glucose, do đó ở bệnh nhân bị bệnh tiểu đường sẽ gia tăng nhu cầu insulin và những thuốc điều trị tiểu đường khác.
- Progesterone có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm chức năng gan hoặc tuyến nội tiết.

Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Mặc dù có thể có kích ứng tại chỗ (do có lecithin đậu nành), không thấy có bất kỳ sự bất dung nạp tại chỗ nào (bong, ngứa hay ra chất nhờn) trong các nghiên cứu lâm sàng khác nhau.

Khi dùng đường uống, các tác dụng không mong muốn sau được ghi nhận:

Thường gặp ($1/100 \leq ADR < 1/10$): thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, mất kinh, chảy máu giữa chu kỳ kinh, nhức đầu

Ít gặp ($1/1000 \leq ADR < 1/100$): buồn ngủ, chóng mặt thoáng qua, chứng vàng da ứ mật, ngứa, rối loạn tiêu hóa. Buồn ngủ và/hoặc chóng mặt thoáng qua được quan sát thấy ở bệnh nhân dùng kết hợp với estrogen liều thấp. Các tác dụng này sẽ mất đi khi giảm liều Utrogestan hoặc tăng liều estrogen mà không ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Chu kỳ kinh nguyệt bị rút ngắn và hoặc chảy máu giữa chu kỳ kinh có thể xảy ra nếu điều trị được bắt đầu quá

thuốc.

- *Trong dọa sinh non*: 400 mg progesterone mỗi 6 đến 8 giờ tùy vào kết quả lâm sàng ở giai đoạn cấp tính, tiếp theo dùng liều duy trì (3 x 200 mg/ngày) đến tuần thứ 36 của thai kỳ.

Đường âm đạo

Liều trung bình là 200 mg progesterone mỗi ngày (1 viên 200 mg hoặc 2 viên 100 mg chia làm 2 lần, 1 viên vào buổi sáng và 1 viên vào buổi tối), đặt sâu vào trong âm đạo.

Liều này có thể tăng tùy theo đáp ứng của từng bệnh nhân.

- *Trường hợp pha hoàng thể bị thiếu hụt một phần (rối loạn rụng trứng, kinh nguyệt không đều)*: 200 mg progesterone mỗi ngày, 10 ngày cho mỗi chu kỳ, thường bắt đầu từ ngày thứ 17 đến ngày thứ 26.
- *Trường hợp vô sinh do pha hoàng thể bị thiếu hụt hoàn toàn (hiến nhiễm bào)*: liều khởi đầu 100 mg progesterone vào ngày thứ 13 và 14 của chu kỳ chuyển phôi, tiếp theo 100 mg progesterone vào buổi sáng và buổi tối từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 25 của chu kỳ. Từ ngày thứ 26 và trong trường hợp có thai, tăng liều lên 100 mg progesterone/ngày mỗi tuần để cuối cùng đạt đến liều tối đa 600 mg progesterone /ngày chia làm 3 lần. Duy trì liều này cho đến ngày thứ 60.
- *Bổ sung giai đoạn hoàng thể trong thụ tinh ống nghiệm*: bắt đầu điều trị vào buổi tối ngày chuyển phôi với liều 600 mg progesterone mỗi ngày, chia làm 3 lần (sáng, trưa và tối)
- *Dọa sảy thai sớm hoặc dự phòng sảy thai liên tiếp do suy hoàng thể*: 200 mg đến 400 mg progesterone mỗi ngày chia làm 2 lần cho đến tuần thứ 12 của thai kỳ.

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Suy gan nặng
- Dị ứng hay mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Điều trị triệu chứng sau mãn kinh: liệu pháp hormone thay thế chỉ nên bắt đầu nếu các triệu chứng này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Trong tất cả các trường hợp, việc đánh giá cẩn thận giữa nguy cơ và lợi ích mà việc dùng thuốc mang lại nên được làm ít nhất một lần mỗi năm. Liệu pháp hormone thay thế chỉ nên tiếp tục nếu lợi ích việc dùng thuốc lớn hơn nguy cơ mà thuốc gây ra.

Các bằng chứng liên quan đến các nguy cơ do việc điều trị tiền mãn kinh với hormone thay thế còn hạn chế. Do nguy cơ thấp ở phụ nữ trẻ tuổi, việc cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ do việc dùng thuốc mang lại có thể dễ được chấp nhận hơn so với phụ nữ cao tuổi.

Utrogestan dạng uống không thích hợp dùng điều trị sinh non hoặc dùng như thuốc ngừa thai.

Chu kỳ kinh nguyệt có thể ngắn hoặc bị chảy máu nếu

sớm, đặc biệt trước ngày 15 của chu kỳ.

Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, mất kinh hoặc chảy máu giữa kỳ kinh đã được ghi nhận liên quan đến sử dụng progestin.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Dùng đường âm đạo, không có trường hợp nào dùng quá liều được ghi nhận.

Với đường uống, những tác dụng không mong muốn được ghi nhận ở trên hầu hết là triệu chứng quá liều. Trong trường hợp giảm liều thì các triệu chứng sẽ tự động hết.

Ở một số bệnh nhân, liều dùng thông thường có thể quá cao, với bằng chứng là nồng độ progesterone nội sinh được tiết ra liên tục hoặc từng đợt mà không được kiểm soát, biểu hiện bằng sự mẫn cảm với thuốc hoặc kèm theo nồng độ oestradiol trong máu thấp. Những lời khuyên sau cho bệnh nhân:

- Giảm liều hoặc dùng progesterone vào buổi tối trước khi đi ngủ, dùng 10 ngày trong một chu kỳ trong trường hợp buồn ngủ hoặc chóng mặt thoáng qua.
- Trong trường hợp ra máu vài giọt hoặc chu kỳ kinh nguyệt bị rút ngắn, việc điều trị nên bắt đầu muộn hơn trong chu kỳ (ví dụ bắt đầu vào ngày thứ 19 thay vì vào ngày thứ 17).
- Phụ nữ tiền mãn kinh/phụ nữ điều trị bằng liệu pháp hormone thay thế nên làm xét nghiệm để đảm bảo nồng độ oestradiol đủ trong máu

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: hormone (nội tiết tố)

Mã ATC: G03DA

Utrogestan chứa progesterone dạng hạt mịn, dùng đường uống và đặt âm đạo làm gia tăng đáng kể nồng độ progesteron trong huyết tương, vì vậy sẽ bổ sung hiệu quả sự thiếu hụt progesterone.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Nồng độ progesterone tăng lên trong giờ thứ nhất và đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương cao nhất sau 1 đến 3 giờ dùng.

Đường uống: Nếu tính thời gian lưu giữ hormone trong mô, cần thiết phải chia liều dùng làm 2 lần cách nhau khoảng 12 giờ để duy trì nồng độ thuốc có hiệu lực suốt 24 giờ trong ngày.

Đường âm đạo: Ở liều khuyến dùng, nồng độ progesterone trong huyết tương ổn định và duy trì, tương đương với nồng độ progesterone đạt được trong pha hoàng thể của một chu kỳ kinh nguyệt rụng trứng bình thường.

Utrogestan dùng đường âm đạo làm tăng trưởng nội mạc tử cung nên rất thích hợp cho sự làm tổ của phôi. Khi tăng dần đến liều cao hơn, thuốc dùng đường âm đạo có thể cho nồng độ progesterone trong máu tương đương với nồng độ được mô tả trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Chuyển hóa: các chất chuyển hóa trong huyết tương và nước tiểu giống như các chất được tiết ra trong

bắt đầu điều trị quá sớm, đặc biệt là trước ngày thứ 15 của chu kỳ.

Trong trường hợp chảy máu tử cung, không được dùng Utrogestan cho đến khi xác định được nguyên nhân, như bằng cách khám nội mạc tử cung.

Do không thể loại trừ hoàn toàn các nguy cơ huyết khối tắc mạch và chuyển hóa, nên ngưng điều trị trong các trường hợp sau:

- Rối loạn mắt như mất thị lực, nhìn đôi, tổn thương mạch máu võng mạc.
- Thuyên tắc tĩnh mạch hoặc huyết khối tắc mạch, bất kể vị trí nào.
- Đau đầu nặng.

Nên kiểm tra chặt chẽ ở bệnh nhân có tiền sử viêm tĩnh mạch huyết khối

Trong trường hợp bị vô kinh đột ngột, phải chắc chắn bệnh nhân không có thai.

Utrogestan có chứa glycerol, có thể gây đau đầu, đầy bụng hoặc tiêu chảy trên bệnh nhân mẫn cảm

Utrogestan có chứa lecithin đậu nành, có thể gây ngứa hoặc sốc phản vệ trên những bệnh nhân mẫn cảm.

Hơn một nửa các trường hợp sảy thai sớm tự phát là do biến chứng di truyền. Các hiện tượng nhiễm khuẩn hoặc các rối loạn cơ học có thể gây sảy thai, đẻ non. Trong các trường hợp này, dùng progesterone chỉ có tác dụng làm chậm thai trứng chết. Vì vậy, chỉ nên dùng progesterone trong các trường hợp hoàng thể tiết ra không đủ.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không có chống chỉ định khi dùng Utrogestan trong thai kỳ kể cả trong những tuần đầu của thai kỳ.

Chưa có nghiên cứu cụ thể progesterone có đi qua sữa mẹ hay không, nên tránh dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

pha hoàng thể. Các chất chuyển hóa chính trong huyết tương là 20- α -hydroxy- Δ -4-pregnenolon và 5- α -dihydroprogesteron. 95 % thuốc được thải qua nước tiểu dưới dạng chất chuyển hóa glucuronid liên hợp. Chất chuyển hóa chính trong nước tiểu là 3 - α -5- β -pregnanediol (pregnandiol).

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI

Utrogestan 100 mg:

Hộp 30 viên nang mềm (2 vỉ x 15 viên)

Utrogestan 200 mg:

Hộp 15 viên nang mềm (1 vỉ x 8 viên và 1 vỉ 7 viên)

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Điều kiện bảo quản: ở nhiệt độ dưới 30°C, trong bao bì gốc.

Hạn dùng: 36 tháng, kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng được ghi trên vỉ và hộp

Tiêu chuẩn chất lượng: tiêu chuẩn cơ sở

Sản xuất bởi

CYNDEA PHARMA S.L

Địa chỉ: Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz
Avenida de Agreda, 31 Olvega 42110 (Soria),

Tây Ban Nha